· 诊疗指南 ·

猴痘诊疗指南(2022 年版)

中华人民共和国国家卫生健康委员会　国家中医药管理局

【关键词】 猴痘病毒; 诊断; 治疗
DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2022.04.001

Guidelines for diagnosis and treatment of monkeypox (2022 version)

National Health Commission of the People's Republic of China, State Administration of Traditional Chinese Medicine

【Key words】 Monkeypox virus; Diagnosis; Therapy
DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2022.04.001

猴痘是一种由猴痘病毒(Monkeypox virus, MPXV)感染所致的人兽共患病毒性疾病,临床上主要表现为发热、皮疹和淋巴结肿大。该病主要流行于中非和西非。2022 年 5 月以来,一些非流行国家也报道了猴痘病例,并存在社区传播。为提高临床医师对猴痘的早期识别及规范诊疗能力,特制定本诊疗指南。

1　病原学

猴痘病毒(MPXV)归类于痘病毒科正痘病毒属,是对人类致病的 4 种正痘病毒属之一,另外 3 种是天花病毒、痘苗病毒和牛痘病毒。电镜下猴痘病毒颗粒呈砖形或椭圆形,大小为 200 nm × 250 nm,有包膜,病毒颗粒中有结构蛋白和 DNA 依赖的 RNA 多聚酶,基因组为双链 DNA,长度约 197 × 10^3 bp。猴痘病毒分为西非分支和刚果盆地分支两个分支。本次非流行国家部分病例病毒测序结果为西非分支。

猴痘病毒的主要宿主为非洲啮齿类动物(包括非洲松鼠、树松鼠、冈比亚袋鼠及睡鼠等)。

猴痘病毒耐干燥和低温,在土壤、痂皮和衣被上可生存数月。对热敏感,加热至 56 ℃ 30 min 或 60 ℃ 10 min 可灭活。紫外线和一般消毒剂均可使之灭活,对次氯酸钠、氯二甲酚、戊二醛、甲醛和多聚甲醛等敏感。

引用格式:中华人民共和国国家卫生健康委员会, 国家中医药管理局. 猴痘诊疗指南(2022 年版)[J]. 中华临床感染病杂志, 2022, 15(4): 241-242. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2022.04.001.

2　流行病学

2.1　传染源　主要传染源为感染猴痘病毒的啮齿类动物。灵长类动物(包括猴、黑猩猩及人等)感染后也可成为传染源。

2.2　传播途径　病毒经黏膜和破损的皮肤侵入人体。人主要通过接触感染动物病变渗出物、血液、其他体液,或被感染动物咬伤、抓伤而感染。人与人之间主要通过密切接触传播,也可通过飞沫传播,接触被病毒污染的物品也有可能感染,还可通过胎盘垂直传播。尚不能排除性传播。

2.3　易感人群　人群普遍易感。既往接种过天花疫苗者对猴痘病毒存在一定程度的交叉保护力。

3　临床表现

潜伏期 5 ~ 21 d,多为 6 ~ 13 d。发病早期出现寒战、发热,体温多在 38.5 ℃以上,可伴头痛、嗜睡、乏力、背部疼痛和肌痛等症状。多数患者出现颈部、腋窝及腹股沟等部位淋巴结肿大。发病后 1 ~ 3 d 出现皮疹。皮疹首先出现在面部,逐渐蔓延至四肢及其他部位,皮疹多呈离心性分布,面部和四肢皮疹较躯干更为多见,手心和脚掌均可出现皮疹,皮疹数量从数个到数千个不等;也可累及口腔黏膜、消化道、生殖器、结膜和角膜等。皮疹经历从斑疹、丘疹、疱疹和脓疱疹到结痂几个阶段的变化,疱疹和脓疱疹多为球形,直径约 0.5 ~ 1 cm,质地较硬,可伴明显痒感和疼痛。从发病至结痂脱落约 2 ~ 4 周。结痂脱落后可遗留红斑或色素沉着,甚至瘢痕,瘢痕持续时间可长达数年。部分患者可出现并发症,包括皮

损部位继发细菌感染、支气管肺炎、脑炎、角膜感染、脓毒症等。

猴痘为自限性疾病，大部分预后良好。严重病例常见于年幼儿童、免疫功能低下人群，预后与感染的病毒分支、病毒暴露程度、既往健康状况和并发症严重程度等有关。西非分支病死率约 3%，刚果盆地分支病死率约 10%。

4　实验室检查

4.1　一般检查　外周血白细胞正常或升高，血小板正常或减少。部分患者可出现转氨酶水平升高、血尿素氮水平降低、低蛋白血症等。

4.2　病原学检查

4.2.1　核酸检测　采用核酸扩增检测方法在皮疹、疱液、痂皮、口咽或鼻咽分泌物等样本中可检测出猴痘病毒核酸。

4.2.2　病毒培养　采集上述样本进行病毒培养可分离到猴痘病毒。病毒培养应当在三级及以上生物安全实验室开展。

5　诊断和鉴别诊断

5.1　诊断标准

5.1.1　疑似病例　出现上述临床表现者，同时具备以下流行病史中的任一项：

（1）发病前 21 d 内有境外猴痘病例报告地区旅居史；

（2）发病前 21 d 内与猴痘病例有密切接触；

（3）发病前 21 d 内接触过猴痘病毒感染动物的血液、体液或分泌物。

5.1.2　确诊病例　疑似病例且猴痘病毒核酸检测阳性或培养分离出猴痘病毒。对符合疑似病例或确诊病例标准的病例，应按相关要求进行传染病报告。

5.2　鉴别诊断　主要和水痘、带状疱疹、单纯疱疹、麻疹和登革热等其他发热出疹性疾病鉴别，还要和皮肤细菌感染、疥疮、梅毒和过敏反应等鉴别。

6　治疗

目前国内尚无特异性抗猴痘病毒药物，主要是对症支持和并发症的治疗。

6.1　对症支持治疗　卧床休息，注意补充营养及水分，维持水、电解质平衡。体温高者，物理降温为主，超过 38.5 ℃，予解热镇痛药退热，但要注意防止大量出汗引发虚脱。保持皮肤、口腔、眼及鼻等部位清洁及湿润，避免搔抓皮疹部位皮肤，以免继发感染。皮疹部位疼痛严重时可予镇痛药物。

6.2　并发症治疗　继发皮肤细菌感染时给予有效抗菌药物治疗，根据病原菌培养分离鉴定和药敏试验结果加以调整。不建议预防性应用抗菌药物。出现角膜病变时，可应用滴眼液，辅以维生素 A 等治疗。出现脑炎时给予镇静、脱水降颅压和保护气道等治疗。

6.3　心理支持治疗　患者常存在紧张、焦虑和抑郁等心理问题，应加强心理支持、疏导和相关解释工作，根据病情及时请心理专科医师会诊并参与疾病诊治，必要时给予相应药物辅助治疗。

6.4　中医治疗　根据中医“审因论治”、“三因制宜”原则辨证施治。临床症见发热者推荐使用升麻葛根汤、升降散及紫雪散等；临床症见高热、痘疹密布、咽痛、多发淋巴结肿痛者推荐使用清营汤、升麻鳖甲汤及宣白承气汤等。

7　出院标准

符合以下标准可以出院：体温正常，临床症状明显好转，结痂脱落。

8　医疗机构内感染预防与控制

疑似病例和确诊病例应安置在隔离病房。疑似病例单间隔离。

医务人员执行标准预防，采取接触预防、飞沫预防措施，佩戴一次性乳胶手套、医用防护口罩、防护面屏或护目镜及一次性隔离衣等，同时做好手卫生。

对患者的分泌物、粪便及血液污染物按照《医疗机构消毒技术规范》进行严格消毒处理。

（收稿日期：2022-07-04）

（本文编辑：彭芳　金建华）

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究